岡山市精神医療審査会
報告書等返戻基準

（令和７年12月８日改訂、令和８年４月１日施行）

Draft

＜ 目 次 ＞

Ⅰ 序文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

Ⅱ 報告書等の記載の原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

Ⅲ 医療保護入院届の審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

Ⅳ 医療保護入院者の入院期間更新届の審査・・・P14

Ⅴ 措置入院決定報告書の審査・・・・・・・・・・・・・・・・P25

Ⅵ 措置入院者の定期病状報告書の審査・・・・・・・P27

別添資料1：報告書等記載例集
別添資料2：報告書等様式（岡山市精神保健福祉法施行細則から抜粋）

Draft

岡山市精神医療審査会の各合議体（以下、「合議体」という。）において行われる「医療保護入院届」「医療保護入院者の入院期間更新届」「措置入院決定報告書」「措置入院者定期病状報告書」（以下、「報告書等」という。）の審査が、入院者の人権確保及び適切な医療と保護を提供することに資するよう、合議体の審査の方針並びに合議体の審査結果に基づく疑義照会及び訂正依頼等（以下、「返戻」という。）の基準を以下のとおり示す。

Ⅰ　序文

令和 7 年度現在、当審査会の合議体は 6 合議体があり、それぞれの合議体は医療委員 2 名、法律家委員 2 名、有識者委員 1 名で構成される。

医療委員は、長年精神科医療に努めてきた精神保健指定医が任命される。

法律家委員は、岡山弁護士会から推薦された弁護士が任命される。

有識者委員は、精神保健福祉士、社会福祉士、精神保健福祉法で定められた社会復帰施設等で勤務し、精神障害者に関する深い知識を有する者が任命される。また、令和 7 年度から精神障害当事者が有識者委員として任命された。

従来、合議体の班長（責任者）は医療委員のみだったが、当審査会では令和 7 年度から一部の合議体の班長は法律家委員が務めることとし、審査において司法の視点をより重視している。

「報告書等」は主として精神保健指定医によって作成されるが、それを審査する委員は上記構成委員であり、医療の必要性だけでなく、司法（人身の自由の抑制の不可避性）・保健福祉（入院治療以外の代替手段による生活の可能性）も含めた多角的な視点をもって審査を行い、審査結果は岡山市長へ通知することとなっている。

そのため、報告書等を作成する精神保健指定医においては、「報告書等」はやむを得ず人身の自由の抑制をすることの不可避性を判定し、行政機関へ結果を通知する根拠となる法的文書であることを十分理解した上で、医療委員以外の法律家委員、有識者委員にも入院者の具体的な症状や治療方針等を文書から読み取ることができ、理解・納得され得る内容である事が必須条件である事に充分留意して作成されたい。

特に、医療保護入院及び入院期間更新の可否は、各報告書の「医療保護入院の必要性」欄の記載内容から判定するので、入院の判断に影響する症状・問題行動等については、他欄の項目を選択・記載するだけではなく、この欄へ具体的に記載することとされたい。

Draft

Ⅱ　報告書等の記載の原則

（審査のポイント：報告書等は法定文書であるので、公用文書としての体裁が整っているかどうか。）

1　誤字脱字等について

誤字脱字及び漢字の誤変換等、明白な誤記載があった場合、原則として事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い補筆訂正する。

例：入院携帯、企死念慮、混迷状態、失検討、現実見当

2　軽微な記載漏れについて

合議体において報告書等の内容を審査するため必要となる事項について、明らかな記載漏れがある場合は、返戻する。ただし、軽微な記載漏れと判断した場合、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い補筆訂正することができるものとする。

例：満年齢が記載漏れとなっているが、生年月日の記載がある

3　判読不能な文字について

判読困難な記載となっている場合は、返戻する。

例：8 ポイント以下の小さい文字、極端な悪筆

4　専門用語、略語等の使用について

専門的な外国語及び略語等は、医療関係者以外の委員にとって分からない場合があるため、それらの記載があった場合は、返戻する。

使用できない略語の例：ASD、AD、PDD、MR、DM、TB、LC、SAH、NASH

ただし、次頁に示す用語については、一般的な用語あるいは報告書等において頻出する用語として当審査会で承認されているため、例外的に使用を認めるものとする。

Draft

使用可能としている用語一覧

使用可能用語 ※アルファベット順	日本語表記
ADL	日常生活動作
ADHD	注意欠陥多動性障害
BPSD	認知症による行動・心理症状
CT	コンピューター断層撮影
DNA	デオキシリボ核酸
HDS-R	長谷川式認知症スケール
m-ECT	修正型電気けいれん療法
MRI	磁気共鳴断層撮影
MMSE	ミニメンタルステート検査
MHSW／PSW	精神保健福祉士
PET	ポジトロン(陽電子)断層撮影
QOL	人生・生活の質
SPECT	単一光子放射型コンピューター断層撮影
WAIS	ウェクスラー成人知能検査
γ-GTP	ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ
服薬アドヒアランス	服薬遵守

Draft

Ⅲ　医療保護入院届の審査

1 「家族等の同意により入院した年月日」「今回の入院年月日」「入院形態の変更」「今回の医療保護入院の入院期間」

（審査のポイント：日付等が正確に記載されているか。入院期間が法定期限を超えていないか。）

（1） 他欄の記載内容と入院日等の整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

（2）「今回の医療保護入院の入院期間」が法定期限（入院から3か月以内）を超えている場合、返戻する。

2 「病名（主たる精神障害、従たる精神障害、身体合併症）」

（審査のポイント：医療保護入院の必要性を示す病名であるか。入院治療に関与する身体合併症が記載されているか。）

（1）記載された病名が他欄の記載内容から妥当でない、又は記載することが望ましい病名が記載されていないと判断した場合、返戻する。

①「主たる精神障害」以外にも入院の必要性に関与する「従たる精神障害」があると判断した場合であって、その記載がない場合。

例：「従たる精神障害」として‘知的障害’があることが他欄の記載内容から読み取れるが、その記載がない場合。

ただし、認知症の周辺症状（せん妄等）により入院となる場合は、病名は‘認知症’のみで可とするが、他欄に周辺症状についての記載・選択があり、医療保護入院の必要性が読み取れる必要がある。

②入院の必要性を判断する上で、「主たる精神障害」と「従たる精神障害」を入れ替えることが適当であると判断した場合。

Draft

例:「主たる精神障害」が統合失調症、「従たる精神障害」が‘知的障害(要治療の行動障害あり)’と記載されているが、他欄の記載内容から今回の入院の理由が明らかに知的障害を起因とした行動障害であると読み取れる場合。

③他欄の記載内容から、他の病名が適当であると判断した場合。

例1:「主たる精神障害」が‘躁病エピソード(F30)’だが、他欄の記載内容から当該入院の躁病エピソードだけでなく、他の躁病又はうつ病エピソードがあると読み取れる場合。(双極性感情障害等の可能性がある場合。)

例2:「主たる精神障害」が‘うつ病(F32)’だが、他欄の記載内容からうつ病エピソードが反復していると読み取れる場合。(反復性うつ病性障害等の可能性がある場合。)

④他欄の記載内容から、今回の入院において重要と考えられる身体合併症があるにもかかわらず、その記載がないと判断した場合。

例1:肺炎、肝硬変、腹水貯留等への医療行為も入院の要因となっていることが他欄の記載内容から読み取れるが、「身体合併症」にその記載がない場合。

例2:「主たる精神障害」が‘器質性精神障害(F06)’だが、「身体合併症」に原因となる身体疾患の記載がない場合。

(2)病名(ICD カテゴリーの下位コードによる状態像の特定含む)が、医療保護入院の必要性を示すものでないと判断した場合、返戻する。

①「主たる精神障害」に‘依存症(アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症等)’を記載している場合。(単に依存症であることは医療保護入院の理由とはならないため。)

②「主たる精神障害」「従たる精神障害」に病名ではなく‘状態像’が記載されている場合。

例:「主たる精神障害」に‘うつ状態(F32)’と記載している場合。
(疑い病名でもかまわないので、病名記載が必要。)

③「主たる精神症状」の ICD カテゴリーが下記ア～イのいずれか場合で、下位コードの桁数が不足している場合。

ア　F43（重度ストレス反応および適応障害）の場合で、コードが英字を含み４桁以上の記載がない場合。
（この病名だけで医療保護入院の理由とはならず、状態像の特定が必要。可能な限り５桁での記載が望ましい。）

例：「主たる精神障害」に‘適応障害（F43）’とのみ記載されている場合。

イ　F7 圏（知的障害）の場合で、コードが英字を含み4桁以上の記載がない、又は４桁目のコードが入院治療を要する程の行動障害を示すものではない場合。
（単に知的障害が医療保護入院の理由とはならず、行動障害がある状態像の特定が必要。）

例1：「主たる精神障害」に‘中等度知的障害（F71）’と記載されている場合。
（４桁目のコードなし）
例2：「主たる精神障害」に‘中等度知的障害（F71.0）’と記載されている場合。
（入院治療を要する程の行動障害を示すコードではない。）

※入院期間更新届は、F1 圏は４桁の F コード記載が必要（P16参照）

３「生活歴及び現病歴」

（審査のポイント：①今回の入院に至る経過の概要がわかる記載となっているか、②病前の社会生活の状況がわかる記載となっているか。）

（1）医療保護入院に至った経過について、日付を含め時系列が分かるような記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：発病時の状況及び発病推定年月の記載がない。
例2：今回、医療保護入院とした入院日についての記載がない。
例3：過去に入退院の経過があるにもかかわらず、その記載がない。

（初回入院及び前回入院の経過、前回入院から今回の入院に至る経過については要記載。それ以外の入院に関して入退院回数が多い場合は‘入退院を繰り返した’‘○回の入院がある’等の表現でも可とする。）

（2）「陳述者」の氏名、続柄に記載誤りがあると判断した場合、返戻する。

例：同意者が法人後見による後見人又は保佐人だが、「陳述者の氏名」に‘法人名’を記載し、「続柄」に‘後見人’又は‘保佐人’と記載している場合。（※「陳述者の氏名」は法人の担当者氏名を記載し、続柄は‘法人後見担当者’と記載することが適切。）

（3）「陳述者」に‘本人’が記載されている場合、返戻する。

理由：入院者本人を陳述者とすることは医療保護入院をさせざるを得ない人からの情報となり、情報の客観性の観点から適当ではないため。

ただし、家族や支援者等、記載できる適当な陳述者がいない場合は、生活歴及び現病歴について情報収集した提出元の病院の精神保健福祉士等でも認める。その場合、続柄は‘当院精神保健福祉士’等と記載されていれば可とする。

（4）他欄の記載内容と整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

例1：「主たる精神障害」「従たる精神障害」の発症の状況・経過に関する記載がない場合。
例2：「初回入院期間」「前回入院期間」「初回から前回までの入院回数」の記載内容と乖離している場合。
例3：他の病院での入院の経過があるにもかかわらず、その記載がない場合。

（5）生活歴、家族歴又は過去の病歴等について入院者の社会生活の状況がわかるような記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：出生時の情報はあるが、それ以外の成育歴の記載がない場合。
例2：病歴、治療歴のみが記載されている場合。

ただし、生活歴等の詳細がわからない場合は、その旨の記載があれば可とする。

Draft

4 「現在の精神症状」

（審査のポイント：今回の医療保護入院時における入院者の精神症状について選択されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「主たる精神障害」「従たる精神障害」から想定される主要な症状及び他欄に記載されている内容に該当する症状が選択されていないと判断した場合、返戻する。

ただし、他欄にそれらの精神症状が明確に記載されており、記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例1：「主たる精神障害」が知的障害又は認知症の場合で、「現在の精神症状」の「Ⅱ知能」の選択及び知能障害の程度の選択がない場合。（知能の障害の程度の選択がない場合は電話確認による補筆訂正ではなく、文書で返戻する。）

例2：「主たる精神障害」が認知症の場合で、BPSD（認知症の行動・心理症状）としての被害関係妄想があるが、「現在の精神症状」の‘Ⅴ知覚　1妄想’の選択がない場合。

※「現在の状態像」については、‘9認知症状態’の選択があれば、BPSD の精神症状についての状態像の選択は必須ではないが、「現在の精神症状」には該当する症状を選択すること。

（2）選択された項目が他欄に記載されている症状・状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「現在の精神症状」の‘Ⅵ感情・情動　3高揚気分’が選択されているが、「医療保護入院の必要性」には抑うつ状態に関する内容のみが記載されている場合。

5 「その他の重要な症状」

（審査のポイント：今回の医療保護入院時における入院者のその他の重要な症状について、選択・記載されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「主たる精神障害」「従たる精神障害」から想定される重要な症状及び他欄に記載されている内容に該当する症状が選択・記載されていないと判断した場合、返戻する。

Draft

ただし、他欄にそれらの精神症状が明確に記載されており、記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例：「主たる精神障害」が‘アルコール離脱せん妄’、「従たる精神障害」に‘アルコール依存症’と記載されているが、「その他重要な症状」の‘3物質依存’が選択されておらず、括弧内に‘アルコール’の記載がない場合。

（2）選択された項目が他欄に記載されている症状・状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「その他重要な症状」の‘2自殺念慮’の選択があるが、「現在の状態像」で「6躁状態」が選択されており、「医療保護入院の必要性」に躁状態の悪化によって入院となった経過のみ記載されている場合。

6 「問題行動等」

（審査のポイント：今回の医療保護入院時における入院者の問題行動について選択・記載されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）他欄に記載されている内容に該当する問題行動が選択・記載されていないと判断した場合、返戻する。

ただし、他欄にそれらの問題行動が明確に記載されており、記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例：「医療保護入院の必要性」に‘放尿・放便を繰り返す’と記載されているが、「問題行動等」の‘3不潔行為’の選択がない場合。

【「問題行動等」の‘4その他’の記載について】

審査においては、入院者の症状だけでなく、症状に伴って生じる「問題行動」も入院の必要性を判定する上で重要な要素である。そのため、入院者の在宅生活、施設生活、一般科病院での入院継続が困難となり得る下記の例のような問題行動について、「4その他」へ記載されているか確認する（「医療保護入院の必要性」に記載されている問題行動を中心に確認する。）

Draft

問題行動等の例：暴力、介護抵抗、自殺企図、自傷行為、迷惑行為、危険行為

（2）選択された項目が他欄に記載されている状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「問題行動等」で‘2徘徊’が選択されているが、他欄には‘現在は寝たきりになっている’と記載されている場合。

7「現在の状態像」

（審査のポイント：<u>今回の医療保護入院時における</u>入院者の主な状態像について選択されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「現在の状態像」がいずれも選択されていない場合、返戻する。

例：項目1～10にいずれも選択がない場合。

（2）「病名」から想定される状態像、他欄に記載されている内容から想定される状態像が選択されていない又は乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「主たる精神障害」が‘アルツハイマー型認知症’だが、「現在の状態像」の‘9認知症状態’の選択がない場合。

ただし、「主たる精神障害」が「認知症（F0 圏）」である場合、BPSD（認知症の行動・心理症状）による状態像は選択がなくても可とする。（例：「主たる精神障害」が‘アルツハイマー型認知症’で、他欄に‘幻視’‘物盗られ妄想’等の記載があるが、それがBPSD だと読み取れる場合、‘1幻覚妄想状態’の選択はなくて可とする。ただし、「現在の精神症状」では該当する症状の選択が必要。）

Draft

8「医療保護入院の必要性」　最重要項目

（審査のポイント：医療保護入院の必要性について、①入院治療が不可欠な程度の病状、②本人の判断能力の低下等、③入院治療への同意の有無の3点を不足なく記載しているか。）

【報告書等を作成される指定医様へ】
医療保護入院の可否は、本欄の記載内容から判定します。入院の判断に影響する症状・問題行動等については、他欄の項目を選択・記載するだけではなく、本欄に具体的に記載してください。
本欄の記載のポイントについては、別添の『報告書等記載例集』を参考にしてください。

（1）入院者の症状の個別性が理解できる記載ではない又は入院治療が不可欠な程度の病状の記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：精神症状、問題行動の用語の記載のみとなっており、それらにかかわる‘本人の発言’‘観察された内容’等の具体的な内容が全く記載されていない又は記載内容が著しく乏しい場合。
例2：他欄に記載されている内容と乖離している場合。

（2）任意入院が行われる状態にないことが理解できる記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：入院治療への同意が得られなかったこと、又は入院同意が一定しないことについて記載がない場合。
例2：同意が得られない、又は同意が一定しない理由に入院者の病識の欠如、入院治療の必要性に対する理解力・判断能力の低下があったことについて記載がない場合。

9「同意をした家族等」

（審査のポイント：医療保護入院を行うにあたって、適切な家族等同意の手続きがとられていることがわかる記載となっているか。）

（1）他欄の記載内容から、同意者の家族等が本人へ虐待加害があると判断される場合、返戻する。

Draft

ただし、他欄に同意者の家族等から本人への虐待加害歴等が記載されているが、入院時点で虐待加害があると判断できない場合は、事務局担当者が病院へ電話確認を行い、入院時点での虐待加害がないことが確認できれば返戻しない。虐待加害があり、同意者として不適当と判断される場合は、同意者の変更（手続き補正）を行い、同意者を変更した入院届を再提出させる。

（2）未成年の入院者の同意者が親権者以外の場合で、その理由が記載されていない場合、返戻する。

例：親権者が虐待加害者等である場合。

（3）未成年の入院者の同意者が両親（親権者）ではなく、父母いずれかの場合で、その理由が記載されていない場合、返戻する。

例 1：両親が離婚しており、親権者が父母のいずれかしかいない場合。
例 2：両親のいずれかが死亡しており、親権者が父母のいずれかしかいない場合。
例 3：父母のいずれかが虐待加害者等である場合。

（4）他欄の記載内容と整合性が取れないと判定した場合又は記載漏れの場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例：「同意をした家族等」と「生活歴及び現病歴」の「陳述者」が同一氏名だが、続柄が一致しない場合。

Draft

Ⅳ　医療保護入院者の入院期間更新届の審査

1 「医療保護入院年月日」「今回の入院年月日」「入院形態の変更」「入院届又は前回の入院期間更新届での入院期間」「本更新後の入院期間」

（審査のポイント：日付等が正確に記載されているか。入院期間更新後の入院期間が法定期限を超えていないか。）

（1）他欄の記載内容と入院日等の整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

（2）「本更新後の入院期間」が法定期限（入院から3か月以内、入院から6か月経過後は6か月以内）を超えている場合、返戻する。

2 「病名（主たる精神障害、従たる精神障害、身体合併症）」

（審査のポイント：入院期間更新の必要性を示す病名であるか。入院治療に関与する身体合併症が記載されているか。）

（1）記載された病名が他欄の記載内容から妥当でない、又は記載することが望ましい病名が記載されていないと判断した場合、返戻する。

①「主たる精神障害」以外にも入院期間更新の必要性に関与する「従たる精神障害」があると判断した場合であって、その記載がない場合。

例：「従たる精神障害」として‘知的障害’があることが、他欄の記載内容から読み取れるが、その記載がない場合。

ただし、認知症の周辺症状（せん妄等）により入院となる場合は、病名は‘認知症’のみで可とするが、他欄に周辺症状についての記載・選択があり、医療保護入院の必要性が読み取れる必要がある。

②入院期間更新の必要性を判断する上で、「主たる精神障害」と「従たる精神障害」を入れ替えることが適当と判断した場合。

Draft

例：入院期間更新時において、入院時の主な症状であったせん妄症状が既に軽減し、認知症による病状が入院期間更新の主な理由であると読み取れるにもかかわらず、いまだに「主たる精神障害」が‘せん妄’で、「従たる精神障害」を‘血管性認知症’と記載している場合。

③他欄の記載内容から、他の病名が適当であると判断した場合。

例1：「主たる精神障害」が‘アルコール離脱せん妄（F10.4）’だが、他欄の記載内容から既に離脱せん妄は消失しており、現在の主たる症状は認知機能障害だと読み取れる場合（認知症等の可能性がある場合。）

例2：「主たる精神障害」が‘うつ病（F32）’だが、他欄の記載内容からうつ病エピソードが反復していると読み取れる場合。（反復性うつ病性障害等の可能性がある場合。）

④他欄の記載内容から、今回の入院期間更新において重要と考えられる身体合併症があるにもかかわらず、その記載がないと判断した場合。

例1：肺炎、肝硬変、腹水貯留等への医療行為も入院の要因となっていることが他欄の記載内容から読み取れるが、「身体合併症」にその記載がない場合。

例2：「主たる精神障害」が‘器質性精神障害（F06）’だが、「身体合併症」に原因となる身体疾患の記載がない場合。

（2）病名（ICD カテゴリーの下位コードによる状態像の特定含む）が、入院期間更新の必要性を示すものでないと判断した場合、返戻する。

①「主たる精神障害」に‘依存症（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症等）’を記載している場合。（単に依存症であることは医療保護入院の理由とはならないため。）

②「主たる精神障害」及び「従たる精神障害」に病名ではなく‘状態像’を記載している場合。

例：「主たる精神障害」に‘うつ状態（F32）’と記載。
（疑い病名でもかまわないので、病名記載が必要。）

③「主たる精神症状」の ICD カテゴリーが下記ア～ウのいずれか場合で、ICD カテゴリーの下位コードの桁数が不足している等、入院治療を要する状態像であることを示していない場合。

ア　F1 圏（精神作用物質使用による精神および行動の障害）の場合で、コードが英字を含み 4 桁以上の記載がない場合。
（入院時点では 3 桁で可。入院期間更新時点では状態像を特定するため 4 桁記載が必要。）

例：入院期間更新時点で‘アルコール離脱せん妄（F10）’と記載。

イ　F43（重度ストレス反応および適応障害）の場合で、コードが英字を含み 4 桁以上の記載がない場合。
（この病名だけで医療保護入院の理由とはならず、状態像の特定が必要。可能な限り 5 桁での記載が望ましい。）

例：「主たる精神障害」に‘適応障害（F43）’とのみ記載されている場合。

ウ　F7 圏（知的障害）の場合で、コードが英字を含み4桁以上の記載がない、又は 4 桁目のコードが入院治療を要する程の行動障害を示すものではない場合。
（単に知的障害が医療保護入院の理由とはならず、行動障害がある状態像の特定が必要。）

例1：「主たる精神障害」に‘中等度知的障害（F71）’と記載している場合。
（4 桁目のコードなし。）
例2：「主たる精神障害」に‘中等度知的障害（F71.0）’と記載している場合。
（入院治療を要する程の行動障害を示すコードではない。）

Draft

3「入院又は前回更新日からの治療内容と、その結果」「症状の経過」

（審査のポイント：入院期間更新前の直近の入院期間における治療内容及び病状又は状態像の経過の概要がわかるような記載となっているか。特に、病状又は状態像の経過が具体的に記載されているかどうかに重点を置く。）

【報告書等を作成される指定医様へ】 **本欄の記載のポイントについては、別添の『報告書等記載例集』を参考にしてください。**

（1）具体的な治療内容の記載がないと判断した場合、返戻する。

（2）更新前の直近の入院期間における入院者の病状・状態像の経過の概要が記載されていない又は記載内容が乏しいと判断した場合、返戻する。

直近の入院期間
・1 回目の入院期間更新時は「入院時から」の内容
・2 回目以降の入院期間更新時は「前回更新日から」の内容

（3）「症状の経過」が選択されていない場合又は選択した項目が「入院又は前回更新日からの治療内容と、その結果」に記載された内容と明らかに乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「症状の経過」では‘1悪化傾向’が選択されているが、「入院又は前回更新日からの治療内容と、その結果」には明らかに症状が改善している内容が記載されている場合。

4「現在の精神症状」

（審査のポイント：今回の入院期間更新時における入院者の精神症状について選択されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「主たる精神障害」「従たる精神障害」から想定される主要な症状及び他欄に記載されている内容に該当する症状が選択されていないと判断した場合、返戻する。

Draft

ただし、他欄にそれらの精神症状が明確に記載されており、記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例1：「主たる精神障害」が‘知的障害’又は‘認知症’の場合で、‘Ⅱ知能’の選択及び知能障害の程度の選択がない場合。（知能の障害の程度の選択がない場合は電話確認による補筆訂正ではなく、文書で返戻する。）

例2：「主たる精神障害」が‘認知症’の場合で、BPSD（認知症の行動・心理症状）としての被害関係妄想があるが、‘Ⅴ知覚　1妄想’の選択がない場合。
※「現在の状態像」の選択については、‘9認知症状態’の選択があれば、BPSDの精神症状についての状態像の選択は必須ではないが、「現在の精神症状」には該当する症状を選択すること。

（2）選択された項目が他欄に記載されている症状・状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「現在の精神症状」の‘Ⅵ感情・情動　3高揚気分’が選択されているが、「医療保護入院の必要性」には抑うつ状態に関する内容のみが記載されている場合。

5　「その他の重要な症状」

（審査のポイント：今回の入院期間更新時における入院者のその他の重要な症状について選択・記載されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「主たる精神障害」「従たる精神障害」から想定される重要な症状及び他欄に記載されている内容に該当する症状が選択・記載されていないと判断した場合、返戻する。

ただし、他欄にそれらの精神症状が明確に記載されており、記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例：「主たる精神障害」が‘アルコール離脱せん妄’で「従たる精神障害」に‘アルコール依存症’と記載されているが、「その他重要な症状」で‘3物質依存’が選択されておらず、括弧内に‘アルコール’の記載がない場合。

（2）選択された項目が他欄に記載されている症状・状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「その他重要な症状」に‘1てんかん発作’の選択があるが、「入院又は前回更新日からの治療内容と、その結果」に‘てんかん発作は 1 年以上抑制されている’と記載されている場合。

6 「問題行動等」

（審査のポイント：<u>今回の入院期間更新時における</u>入院者の問題行動について選択・記載されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）他欄に記載されている内容に該当する問題行動が選択・記載されていないと判断した場合、返戻する。

ただし、他欄にそれらの問題行動が明確に記載されており、<u>記載漏れと判断できる場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。</u>

例：「医療保護入院の必要性」に「放尿・放便を繰り返す」と記載されているが、「3不潔行為」の選択がない場合。

【「問題行動等」の‘4その他’の記載について】

審査においては、入院者の症状だけでなく、症状に伴って生じる「問題行動」も入院の必要性を判定する上で重要な要素である。そのため、入院者の在宅生活、施設生活、一般科病院での入院継続が困難となり得る下記の例のような問題行動について、「4その他」へ記載されているか確認する（「医療保護入院の必要性」に記載されている問題行動を中心に確認する。）

問題行動等の例：暴力、介護抵抗、自殺企図、自傷行為、迷惑行為、危険行為

Draft

（2）選択された項目が他欄に記載されている状態像と乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「2徘徊」が選択されているが、他欄には「現在は寝たきりになっている。」と記載されている場合。

7「現在の状態像」

（審査のポイント：<u>今回の入院期間更新時における</u>入院者の主な状態像について選択されており、他欄と整合性が取れているかどうか。）

（1）「現在の状態像」がいずれも選択されていない場合、返戻する。

例：項目1～10にいずれもチェックがない場合。

（2）「病名」から想定される状態像、他欄に記載されている内容から想定される状態像が選択されていない又は乖離していると判断した場合、返戻する。

例：「主たる精神障害」が‘アルツハイマー型認知症’だが、「現在の状態像」の‘9認知症状態’の選択がない場合。

ただし、「主たる精神障害」が「認知症（F0 圏）」である場合、BPSD（認知症の行動・心理症状）による状態像は選択がなくても可とする。（例：「主たる精神障害」が‘アルツハイマー型認知症’で、他欄に‘幻視’‘物盗られ妄想’等の記載があるが、それが BPSD だと読み取れる場合、‘1幻覚妄想状態’の選択はなくて可とする。ただし、「現在の精神症状」では該当する症状の選択が必要。）

Draft

8「医療保護入院の必要性」　最重要項目

（審査のポイント：医療保護入院の必要性について、①入院治療が不可欠な程度の病状、②本人の判断能力の低下等、③入院治療への同意の有無の3点を不足なく記載しているか。）

【報告書等を作成される指定医様へ】
入院期間更新の可否は、本欄の記載内容から判定します。入院期間更新の判断に影響する症状・問題行動等については、他欄の項目を選択・記載するだけではなく、本欄に具体的に記載してください。
本欄の記載のポイントについては、別添の『報告書等記載例集』を参考にしてください。

（1）入院者の症状の個別性が理解できる記載ではない又は入院治療が不可欠な程度の病状の記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：精神症状、問題行動等の用語の記載のみとなっており、それらにかかわる‘本人の発言’‘観察された内容’等の具体的な内容が全く記載されていない又は記載内容が著しく乏しい場合。
例2：他欄に記載されている内容と乖離している場合。

（2）任意入院が行われる状態にないことが理解できる記載がないと判断した場合、返戻する。

例1：入院治療への同意が得られなかったこと、又は入院同意が一定しないことについて記載がない場合。
例2：同意が得られない、又は同意が一定しない理由に入院者の病識の欠如、入院治療の必要性に対する理解力・判断能力の低下があったことについて記載がない場合。

Draft

9　「今後の治療方針」

（審査のポイント：入院期間更新後も入院者へ適切な医療が提供されることがわかるような記載となっているか。）

【報告書等を作成される指定医様へ】 **本欄の記載のポイントについては、別添の『報告書等記載例集』を参考にしてください。**

（1）入院者の個別性に配慮した治療方針の記載がないと判断した場合、返戻する。

例：漠然とした治療法のみ記載されている場合。

（2）入院者の病識や治療意欲を獲得するための取り組みについて記載がないと判断した場合、返戻する。

例：「薬物治療を継続する」とのみ記載されている場合。

10「退院に向けた取組の状況」（本欄は退院後生活環境相談員が記載）

（審査のポイント：退院後生活環境相談員の取り組み状況がわかるような記載となっているか。）

（1）退院支援委員会において決定した内容について記載がないと判断した場合、返戻する。

例：退院支援委員会に関する記載がない場合。

（2）想定している退院後の生活についての記載がない場合、又は退院に向けた取組に関する記載が不十分と判断した場合、返戻する。

例1：退院後生活環境相談員との相談状況及び地域援助事業者の紹介状況等の記載がない場合。
例2：家族が退院に反対しているため、退院について話が進まない等の記載しかなく、環境調整が必要な場合の環境調整の方向性についての記載がない場合。

（3）他欄及び退院支援委員会審議記録の記載内容と整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

Draft

11 「今回の更新の直前の入院又は更新に同意をした家族等」「今回の更新に同意をした家族等」

（審査のポイント：医療保護入院の入院期間更新を行うにあたって、適切な家族等同意の手続きがとられていることがわかる記載となっているか。）

（1）他欄の記載内容から、同意者の家族等が本人へ虐待加害があると判断される場合、返戻する。

ただし、他欄に同意者の家族等から本人への虐待加害歴等が記載されているが、入院時点で虐待加害があると判断できない場合は、事務局担当者が病院へ電話確認を行い、入院時点での虐待加害がないことが確認できれば返戻しない。虐待加害があり、同意者として不適当と判断される場合は、同意者の変更（手続き補正）を行い、同意者を変更した入院届を再提出させる。

（2）未成年の入院者の同意者が親権者以外の場合で、その理由が記載されていない場合、返戻する。

例：親権者が虐待加害者等である場合。

（3）未成年の入院者の同意者が両親（親権者）ではなく、父母いずれかの場合で、その理由が記載されていない場合、返戻する。

例1：両親が離婚しており、親権者が父母のいずれかしかいない場合。
例2：両親のいずれかが死亡しており、親権者が父母のいずれかしかいない場合。
例3：父母のいずれかが虐待加害者等である場合。

（4）他欄及び退院支援委員会審議記録の記載内容と整合性が取れないと判定した場合、又は記載漏れの場合は、事務局担当者が提出者に対して電話等で確認を行い、補筆訂正できるものとする。

例：「今回の更新の直前の入院又は更新に同意をした家族等」の同意者は‘長男’となっているが、退院支援委員会審議記録に記載されている同一名の家族の続柄が‘次男’と記載されている場合。

Draft

12 「医療保護入院者退院支援委員会審議記録（添付書類）」

（審議記録は退院後生活環境相談員が作成）

（1）退院支援委員会審議記録の記載内容と入院期間更新届の記載内容との間で整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

例1：審議記録の「現在の入院期間」「更新後の入院期間」が、入院期間更新届の「入院又は前回の入院期間更新届での入院期間」「本更新後の入院期間」と一致しない場合。

例2：審議記録の「入院期間の更新の必要性の有無とその理由／退院に向けた具体的な取組」が、入院期間更新届の「医療保護入院の必要性」「今後の治療方針」「退院に向けた取組の状況」に記載している内容と乖離している場合。

　ただし、令和 4 年法改正により令和6年4月以降は、本人及び家族等への退院支援委員会の審議結果は、退院支援委員会審議記録の写しをもって通知することとなったため、審議記録の記載内容を本人及び家族等が理解しやすいような表現とすることは差し支えない。よって、入院期間更新届と審議記録の記載内容の表現を厳密に一致することまでは求めない。

例3：出席者に、主治医、担当看護職員、退院後生活環境相談員の氏名が全て記載されていない場合返戻する。（委員会の成立要件）

　ただし、上記の職員がやむを得ない理由で急遽参加できなかった場合、同職種の代理の職員が参加し、その旨を審議記録へ記載していれば委員会は成立しているとし、返戻しない。

例4：本人及び家族等が委員会に参加しているにもかかわらず、「本人及び家族等の意見」が記載されていない場合、返戻する。

〔備考　本人及び家族等の意見の記載について〕

・本人及び家族等が委員会に参加しない場合であっても、事前に意見の聴取に努め、意見が聴取できた場合は審議記録に記載されていることが望ましい。

・委員会審議記録の写しは本人及び家族等へ結果通知として交付することとなっているが、家族等の意見を記載した審議記録の写しを本人へ交付することで、本人の病状悪化や家族関係の悪化等の可能性がある等、治療上の観点から家族等の意見を審議記録に記載することが望ましくない場合がある。このような場合は、家族等が委員会に参加していたとしても、委員会審議記録への家族等の意見の記載はなくても可とする。（事務局からの電話確認等でその理由が確認できた場合は、返戻しない。）

Draft

Ⅴ　措置入院決定報告書の審査

（審査のポイント：措置入院時点において、医療及び保護のために直ちに入院させなければその精神障害のために自傷行為又は他害行為を引き起こすおそれが著しいかどうか）

【審査書類（岡山市保健所から提出）】

・措置入院決定報告書
・措置入院等診断書（一次診察及び二次診察のもの）

上記の報告書・診断書に加え、岡山市保健所が作成している「緊急対応報告書」に記載されている、通報受理、事前調査、措置診察等の内容を審査の参考にできることとする。なお、「緊急対応報告書」については法定提出義務がないため、返戻による文書補正は求めないこととする。

【返戻先について】

措置入院決定報告書は岡山市保健所が当審査会へ審査を求めるものであるため、返戻は岡山市保健所へ行う。
（措置入院等診断書の補正が必要な場合であっても、措置診察を行った指定医に直接返戻は行わず、岡山市保健所を経由して行う。）

【主に審査する項目】

１「重大な問題行動（A は今までの、B は今後おそれのある行動）」

（1）‘今後の’自傷他害のおそれの判断にかかわる「B」が選択されており、その問題行動が「診察時の特記事項」等に記載されている内容と乖離していないか。

２「病名」「現在の精神症状」「現在の状態像」

（1）対象者が精神障害者であり、精神症状を有していることがわかるよう、病名及症状・状態像が適切に記載、選択されており、「診察時の特記事項」等に記載されている内容と乖離していないか。

３「診察時の特記事項」

（1）診察時の対象者の様子、精神症状、自傷他害のおそれ（重大な問題行動）について具体的記載されているか。

Draft

〔備考　措置入院決定報告書の審査について〕

・一次診察及び二次診察で病名や状態像の相違があることのみを持って返戻とはせず、審査書類から総合的に判断するか、二次診察（措置入院決定）時点での診断名及び状態像を基本に審査する。（移送手続き中に本人の状態が変化する場合や、指定医によって診断が異なる場合はあり得るため。）

・一次診察及び二次診察の診断書の内容において、自傷他害にかかわる問題行動が乖離している等、何をもって自傷他害のおそれがあると判断したのか不明瞭な場合は、必要に応じて返戻する。

Draft

Ⅵ 措置入院者の定期病状報告書の審査

（審査のポイント：①措置入院を継続する必要性（精神症状による自傷他害のおそれ）が判断できるような記載となっているか、②今後も措置解除に向けて適切な治療が提供されることがわかる記載となっているか。）

※ 措置入院者定期病状報告書に係る下記の1～5以外の項目については、医療保護入院者の入院期間更新届の返戻基準に準ずる。

1 「過去6箇月間（措置入院後3か月の場合は過去3か月間）の治療の内容及びその結果」

（1）措置入院時又は前回の報告から今回の報告までの間に実施された治療・看護等に関する記載が入院者の個別性に配慮したものではないと判断した場合、返戻する。

（2）措置入院を継続する理由（自傷他害のおそれ）について、過去 6 箇月間の治療による変化および残存する自傷他害にかかわる問題行動の具体的な記載がないと判断した場合、返戻する。

ただし、「診察時の特記事項」に具体的な記載があると判断した場合は、この限りでない。

2 「今後の治療方針」

（1）入院者の個別性に配慮した治療方針の記載がないと判断した場合、返戻する。

例：漠然とした治療法のみ記載している場合。

（2）自傷他害にかかわる問題行動への再発防止の取り組みについて記載がないと判断した場合、返戻する。

例：「薬物治療を継続する」とのみ記載している場合。

Draft

３「処遇、看護及び指導の現状」

（1）他欄の記載内容と整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

４「重大な問題行動」

（1）措置入院を継続する理由となる重大な問題行動が選択されていない場合、返戻する。

（2）選択した内容が、他欄の記載内容と整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

５「診察時の特記事項」

（1）精神症状、自傷他害のおそれ（重大な問題行動）が継続していることついて具体的に記載されていない場合、返戻する。

（2）他欄と整合性が取れないと判断した場合、返戻する。

Draft

Draft

＜岡山市精神医療審査会返戻基準＞

制定　平成29年7月27日制定

（平成29年度岡山市精神医療審査会全体会議で議決）

改訂　平成30年4月1日

改訂　令和7年12月8日

（令和7年度岡山市精神医療審査会全体会議で議決。令和8年4月1日施行）